

Procedimientos de Ortopedia

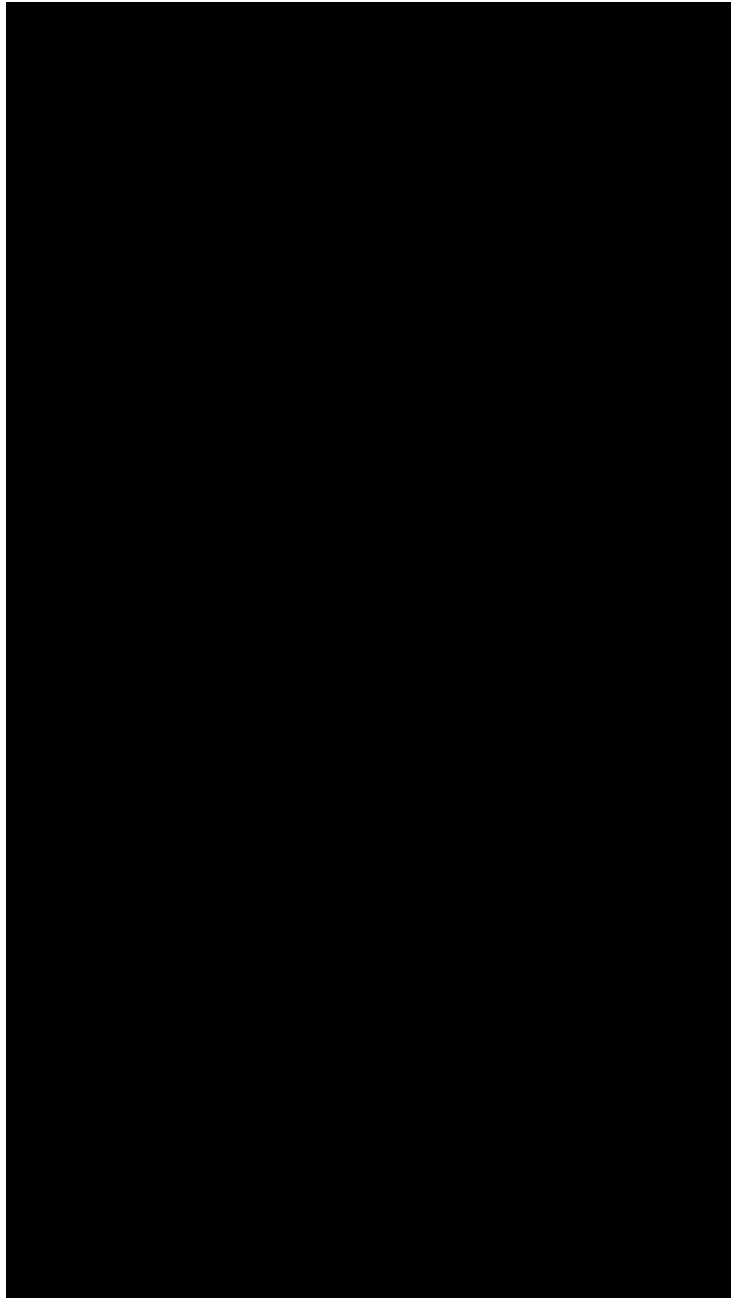
SEMANA 3

Coxa Valga/Coxa Vara

Presente.

Lic.TF Wendy Pacompia Bustincio

¿Qué alteraciones posturales pueden presentarse en etapas tempranas?



TEMARIO:



Coxa valga, Coxa vara

Anatomía y fisiología articular

Etiología

Tratamiento ortopédico

Tratamiento quirúrgico

Tratamiento Rehabilitador

Genu varo, Genu valgo

Anatomía y fisiología articular

Etiología

Tratamiento ortopédico

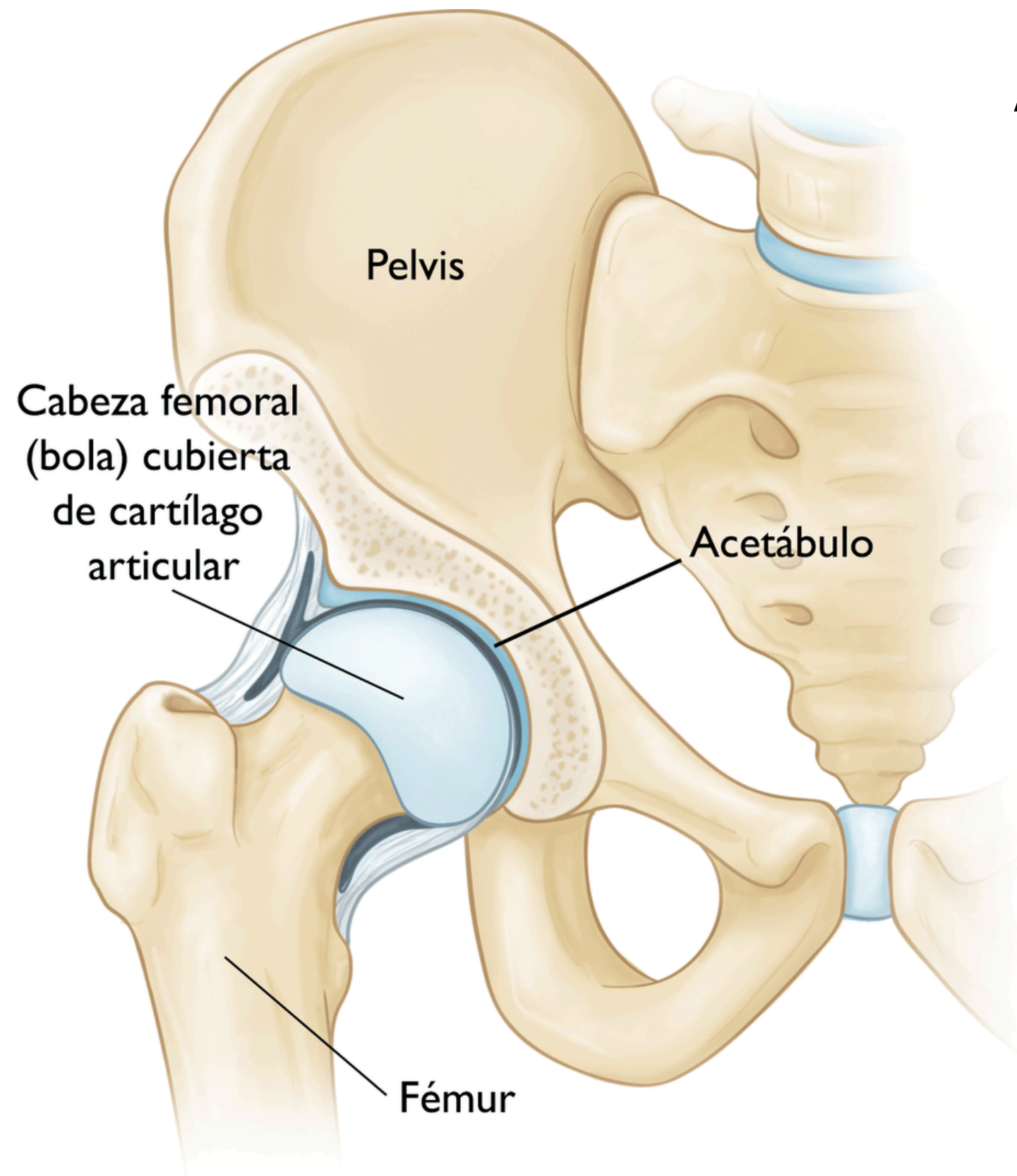
Tratamiento quirúrgico

Tratamiento Rehabilitador

Tibias varas

1. Etiología

2. Tratamiento ortopédico



ARTICULACIÓN DE LA CADERA

Referencias anatómicas:

Superficies articulares:

Tipo de articulación:

Ligamentos:

Músculos de la cadera:

Inervación:

Movimientos articulares(planos):

**Posición de máxima coaptación
articular:**

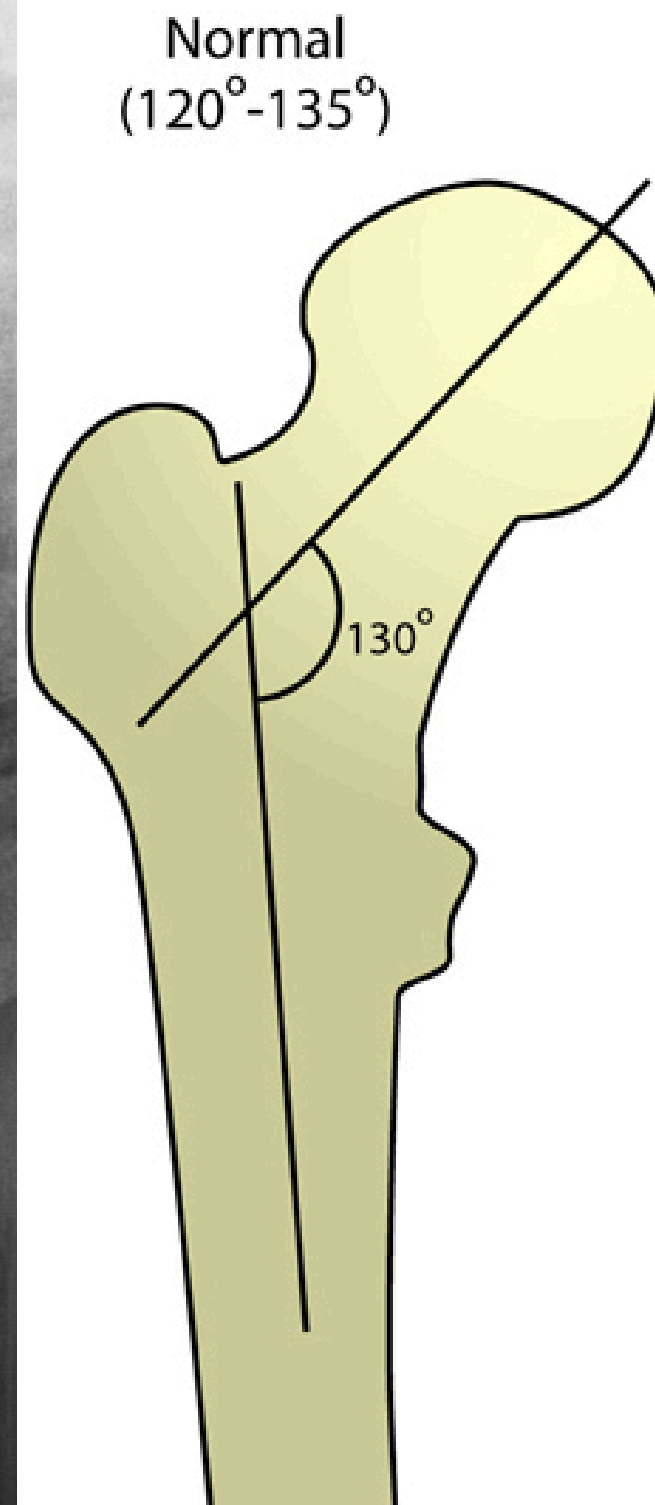
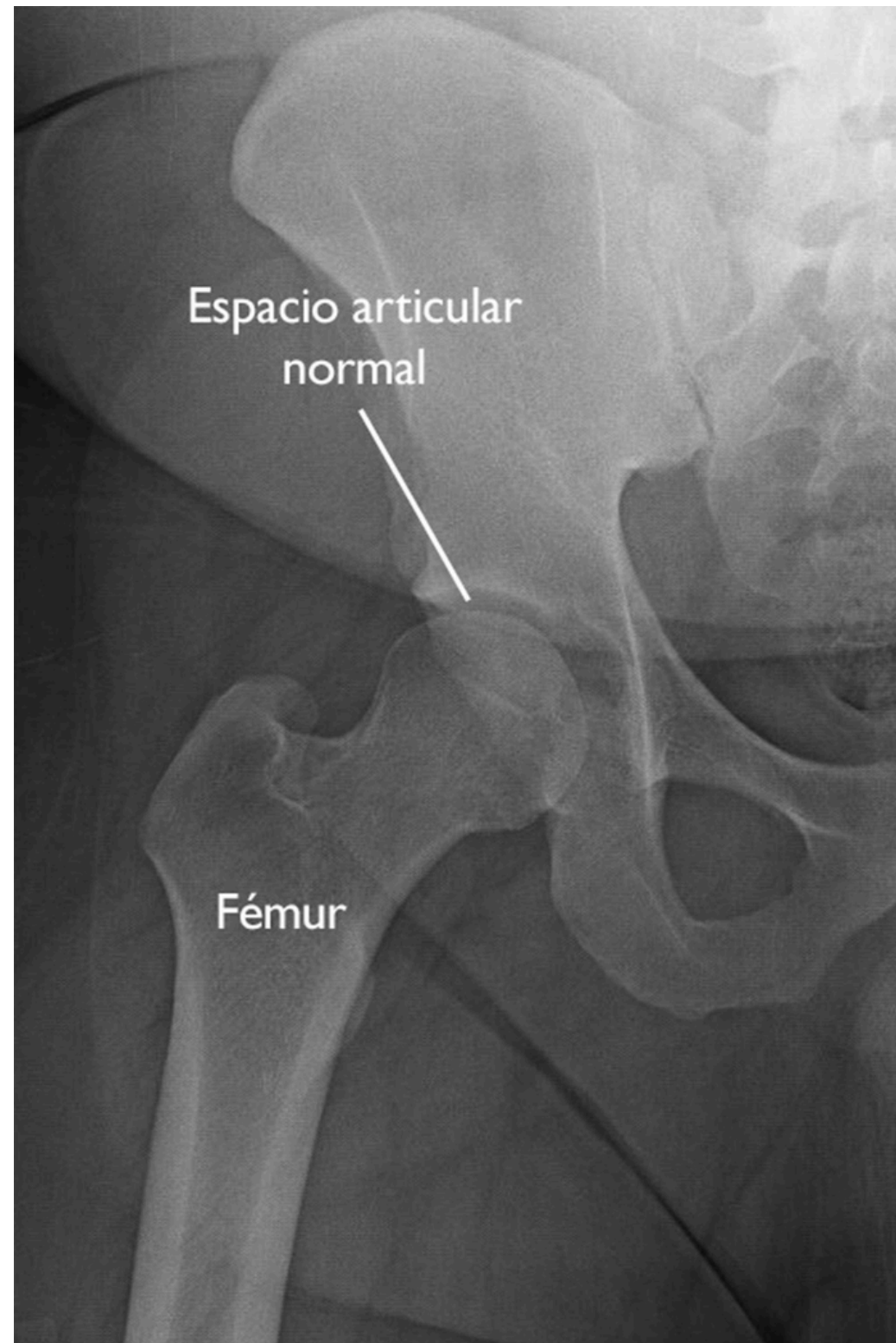


[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player configuration error

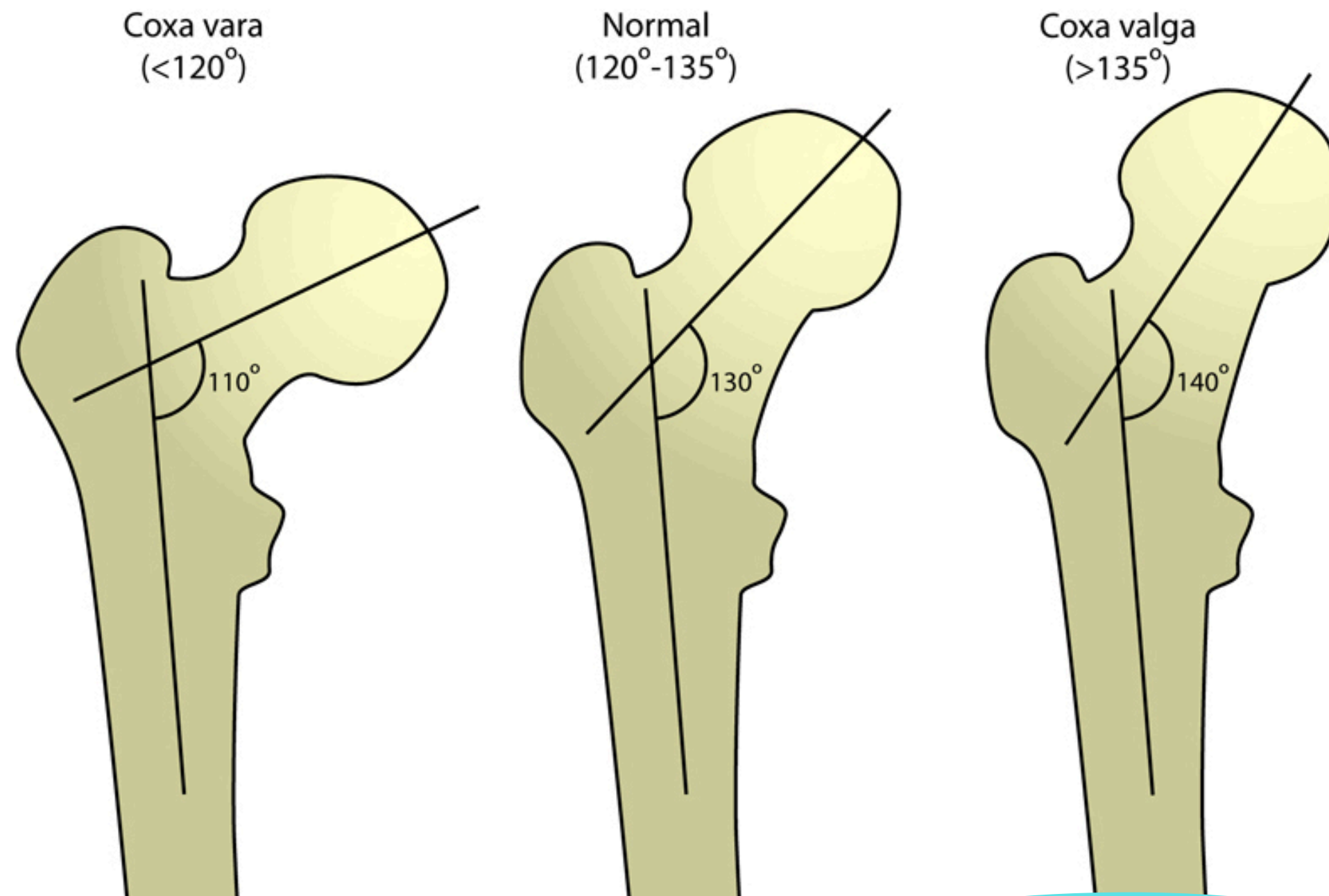




Ángulo CervicoDiafisario

El ángulo cervicodiafisario es el ángulo formado por la intersección entre el eje del cuello femoral y el eje diafisario del fémur, medido en una radiografía en vista anteroposterior.

Edad	Ángulo CD
RN	150°
3 AÑOS	145°
6 AÑOS	140°
8 AÑOS	135°
Adulto	120°



COXA VALGA

Es el aumento del ángulo CD más de 135° , por lo que existe un AUMENTO DE LA PRESIÓN EN LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA y LA REDUCCIÓN de la presión en cuello femoral.

COXA VARA

Es la disminución del ángulo CD, inferior a 120° . La presión en la articulación de la cadera está disminuida y aumentada en el cuello femoral.

Son deformidades que se observan en el plano frontal como el resultado de la alteración de los ejes longitudinales de los huesos largos de los MMII.

CAUSAS:

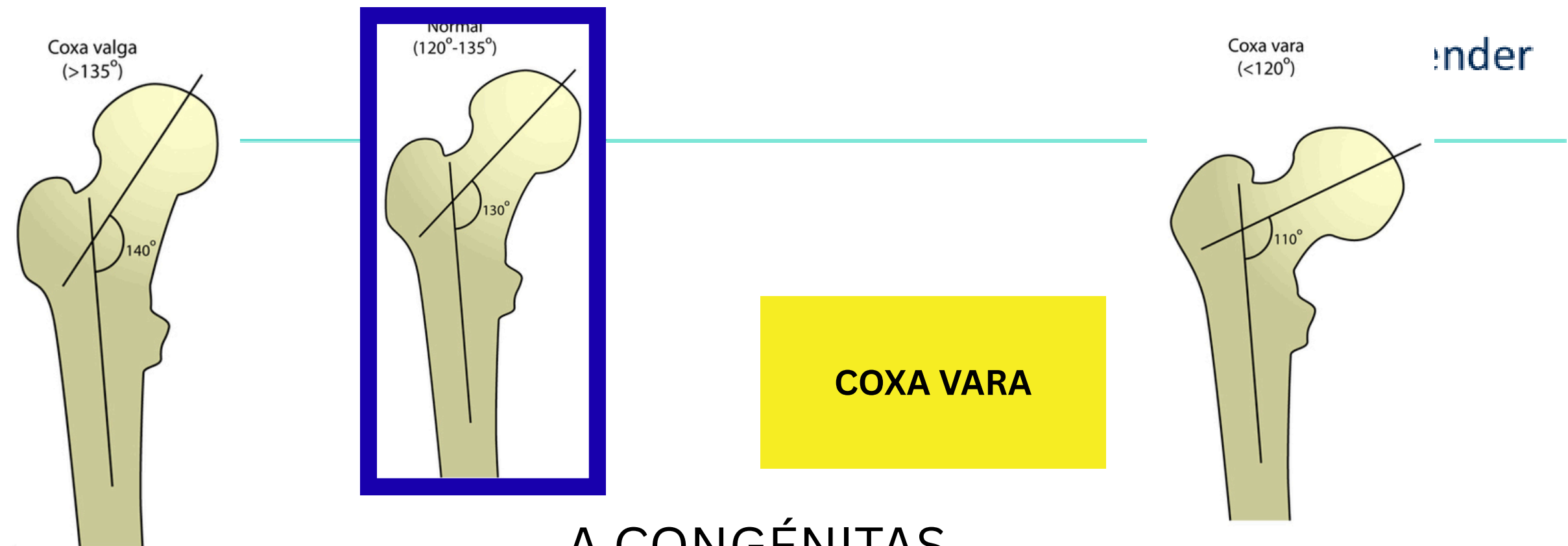
COXA VALGA

A. CONGÉNITAS

- Displasias

B. ADQUIRIDAS

- Trastornos del crecimiento
- Desequilibrios musculares (Parálisis)
- Fracturas de cuello femoral mal consolidadas.
- Tumores e inflamaciones
- Parálisis cerebral infantil.
- Retraso psicomotor



A. CONGÉNITAS

- Defectos óseos y displasias óseas

B. Asociado a otros trastornos

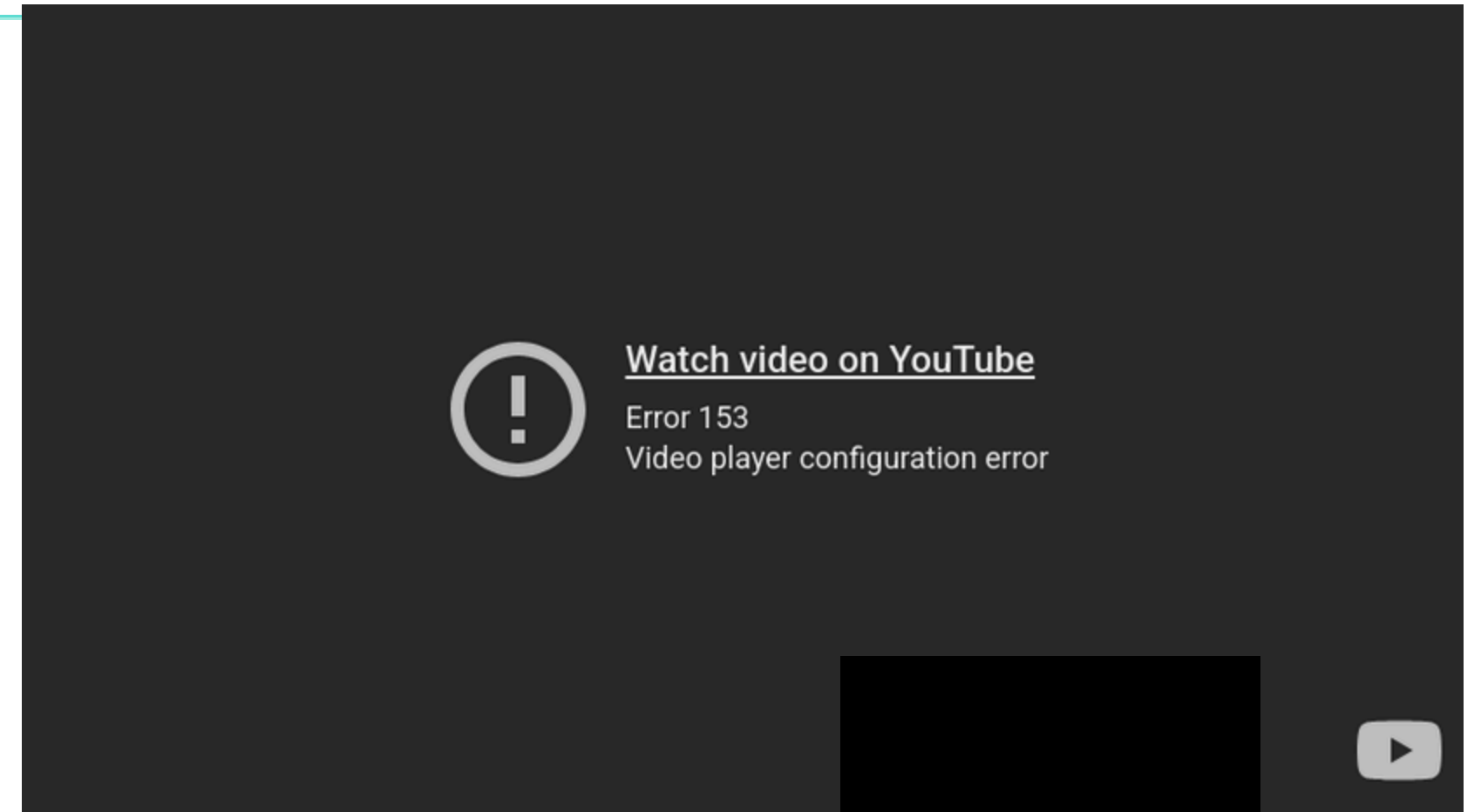
- Fracturas mal consolidadas
- Necrosis avascular
- Tumores
- Osteopenia
- Raquitismo
- Post osteotomía

CUADRO CLÍNICO

Los síntomas principales de la coxa valga y la coxa vara son dolor en la cadera y la rodilla, cojera, y limitación del movimiento de la pierna. La coxa vara puede causar una marcha de pato o una pierna más corta, mientras que la coxa valga, especialmente en niños, a veces no presenta síntomas o puede causar dolor en niños mayores.

¿Diagnóstico?

La coxa valga y la coxa vara se suelen diagnosticar en la infancia, a menudo entre los tres y los seis años. En el caso de la coxa vara, puede manifestarse cuando el niño comienza a caminar y el diagnóstico temprano (antes de los 12 años) es común.



TRATAMIENTO ORTÉSICO

Basado en la gravedad de la deformidad, la alteración funcional y la evidencia que la deformidad es progresiva.



Ortesis de Perthes



Ortesis para Contención de la Cadera

Objetivo: Centraje y contención de la cadera.



Ortesis de cadera bilateral

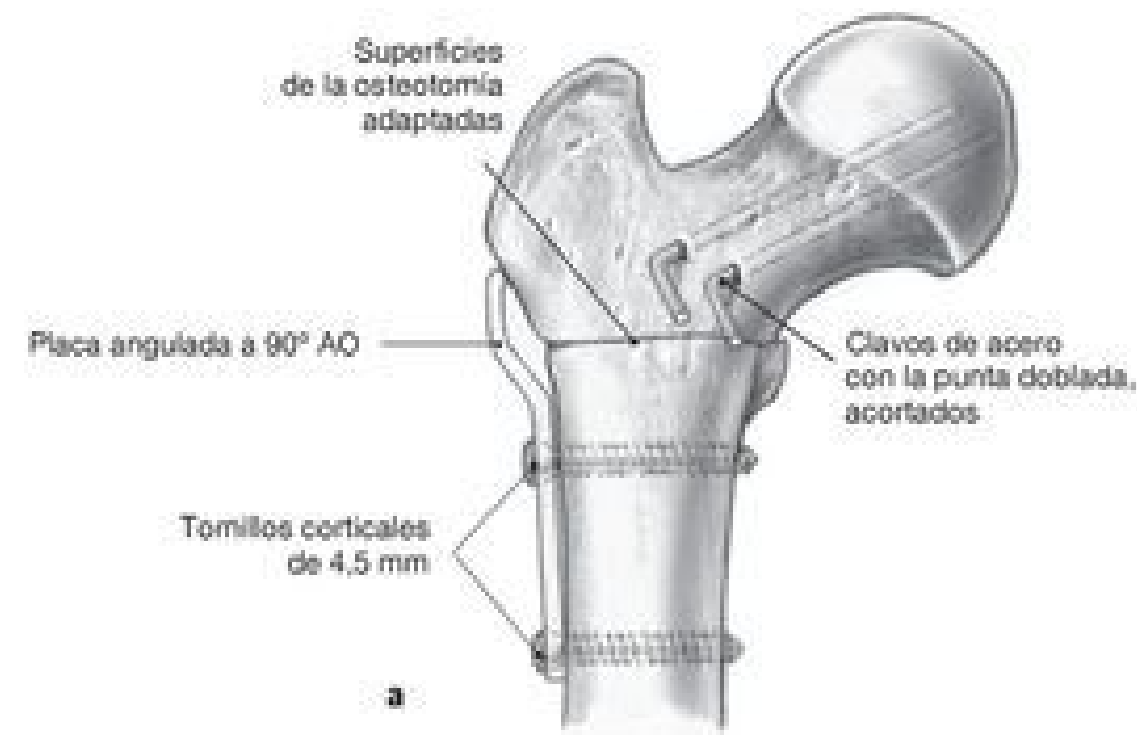
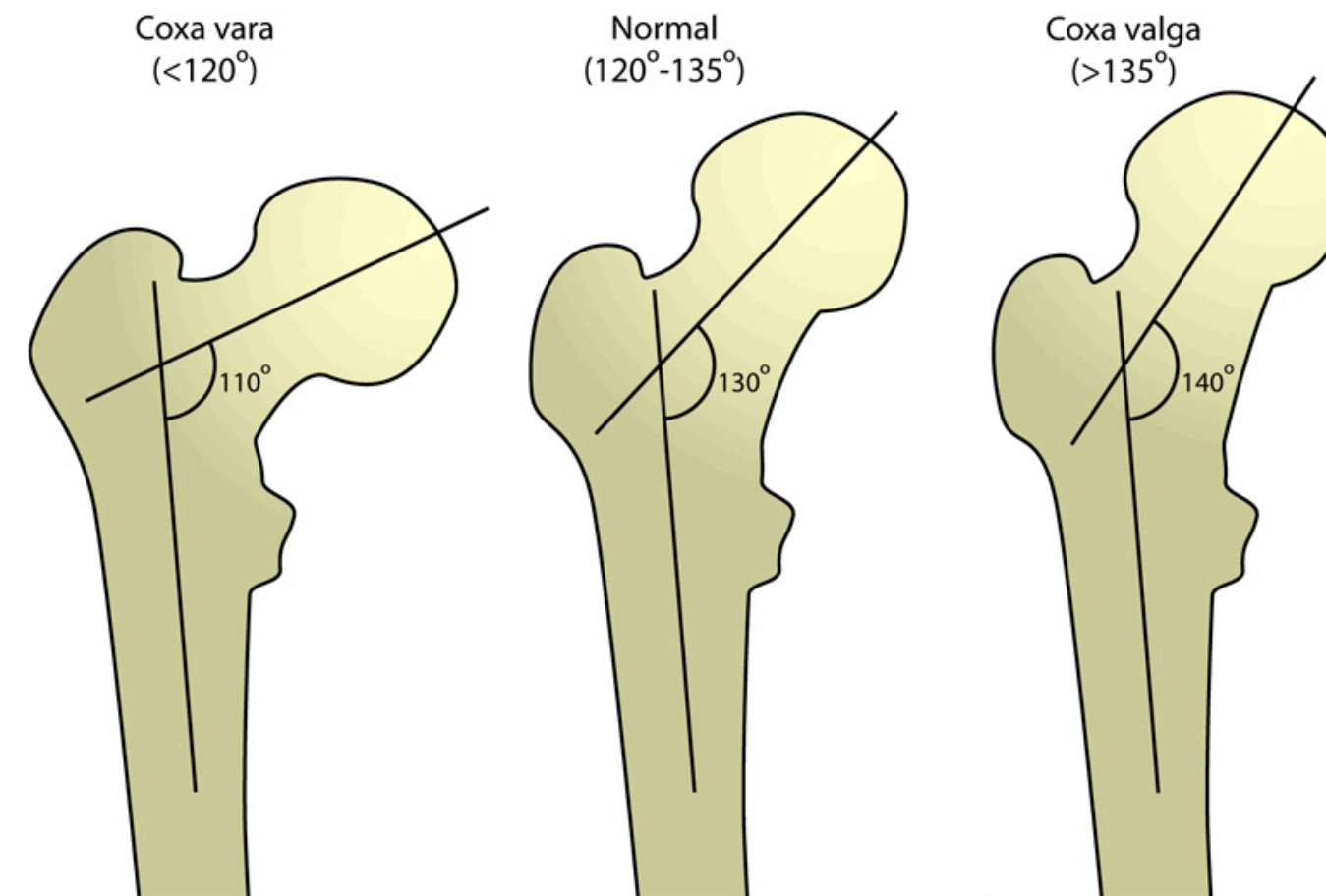
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

**COXA VARA: Osteotomía
valguizante**

intertrocantérea

COXA VALGA:

**Osteotomía varizante
intertrocantérea**



Watch video on YouTube
Error 153
Video player configuration error

Watch video on YouTube
Error 153
Video player configuration error

TRATAMIENTO REHABILITADOR

OBJETIVO GENERAL:

- Disminuir el ángulo CD y mejorar la congruencia articular.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Preparar y mejorar tono muscular.
- Mejorar movilidad/Equilibrar las tensiones musculares,
- Fortalecer musculatura selectivamente.
- Mejorar control postural.
- Estimular la bipedestación precoz y reeducar la marcha.

OBJETIVO GENERAL

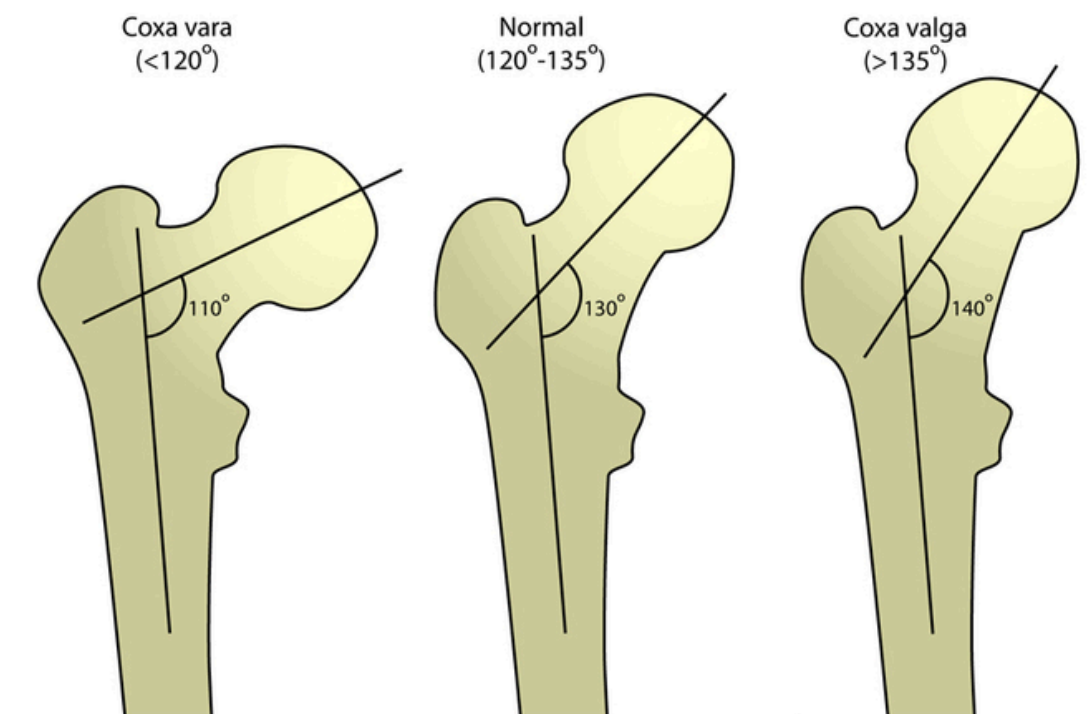
- Prevenir la disminución del ángulo CD y preservar la función de la articulación de la cadera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

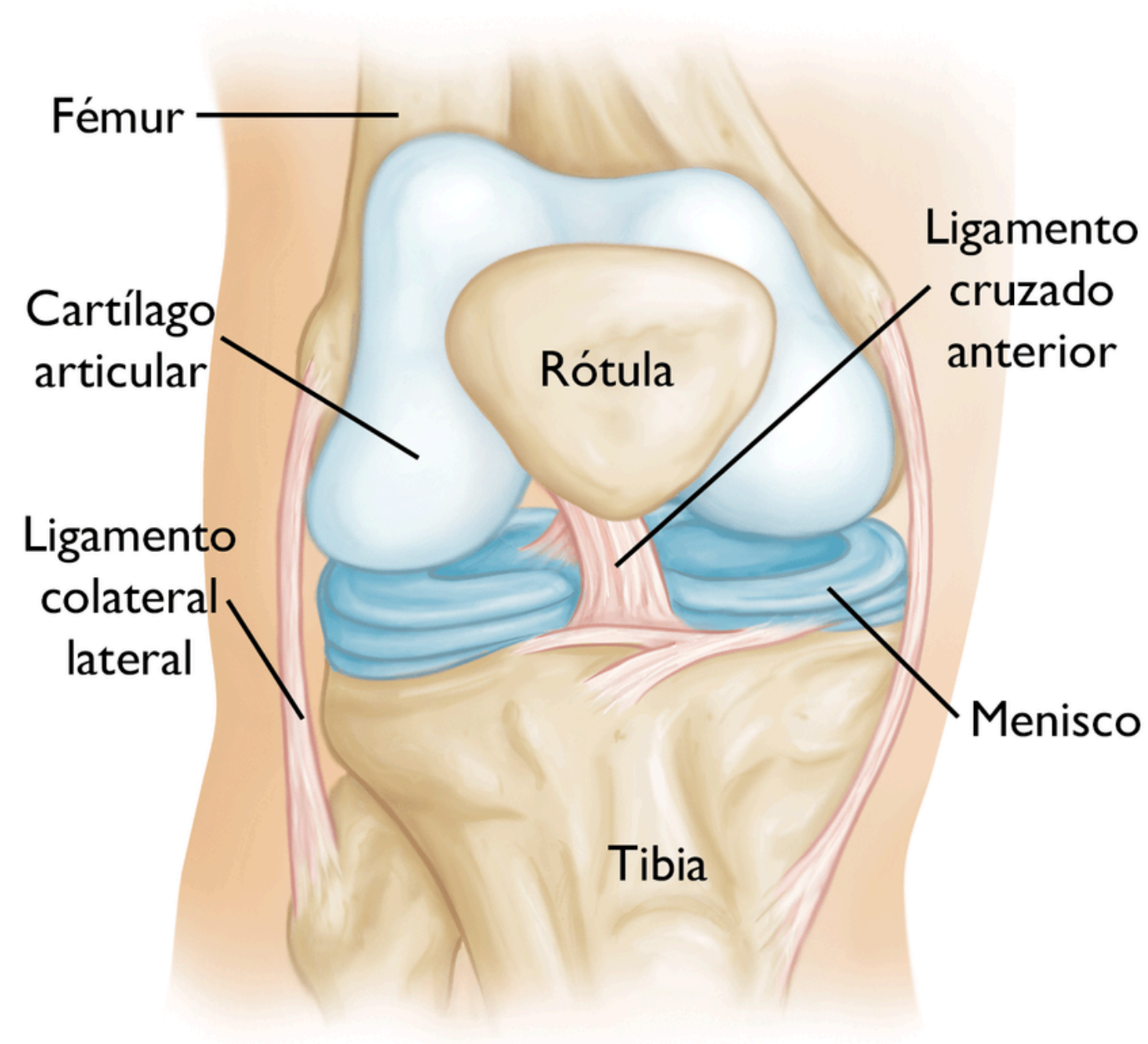
- Preparar y mejorar tono muscular.
- Mejorar movilidad/Equilibrar las tensiones musculares.
- Fortalecer musculatura selectivamente.
- Prevenir y corregir deformidades.
- Disminuir las sobrecargas funcionales.

COXA VALGA

COXA VARA



ARTICULACIÓN DE LA RODILLA



Referencias anatómicas:

Superficies articulares:

Tipo de articulación:

Ligamentos:

Músculos de la rodilla:

Inervación:

Movimientos articulares(planos):

**Posición de máxima coaptación
articular:**



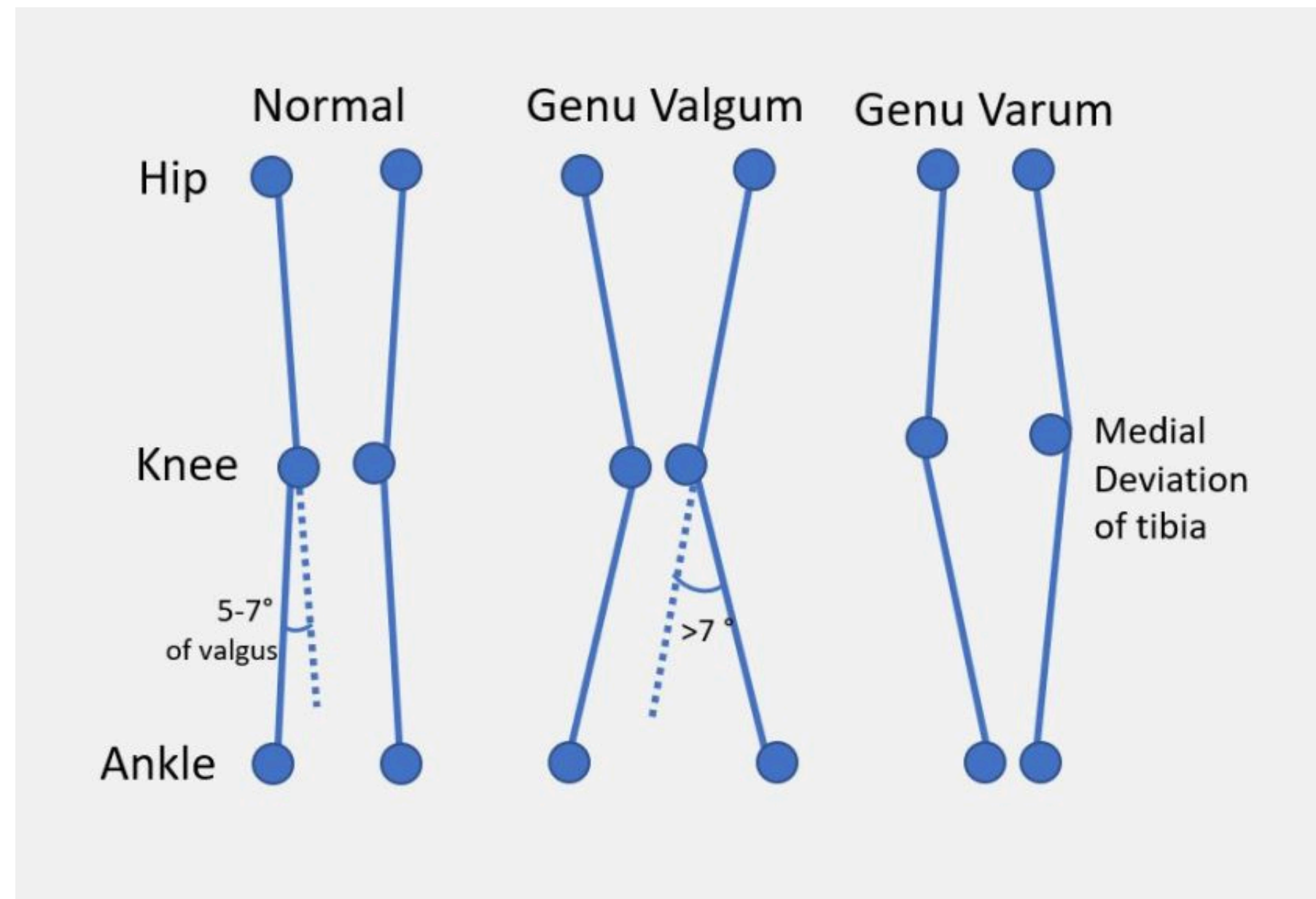
[Watch video on YouTube](#)

Error 153
Video player configuration error



ÁNGULO FEMOROTIBIAL

El ángulo femorotibial es la medida del ángulo formado por el eje anatómico del fémur y el eje anatómico de la tibia en el plano frontal. Un ángulo normal en la alineación de la rodilla en valgo es de aproximadamente 5° a 7°.



En recién nacidos predomina el varo (rodillas separadas), pero a los 4 años se alcanza un valgo máximo y luego disminuye gradualmente hasta los 5°-7° en la adultez.

GenuVaro/GenuValgo

Son deformidades de la rodilla en el plano frontal. Están influenciadas por: la presión anómala derivada de una mala posición al dormir o jugar, sostenida por largos periodos de tiempo.

Los malos hábitos posturales influyen negativamente sobre el SME de un niño en desarrollo, impidiendo una buena formación de sus MMII, porque en gran parte el aparato locomotor, está formado por cartilago, que es muy maleable y susceptible a deformidades.



GENU VARO



GENU VALGO



Al inicio la alteración es solo de partes blandas(fisiológico), pero con el paso del tiempo la deformidad se hace ósea(patológica)

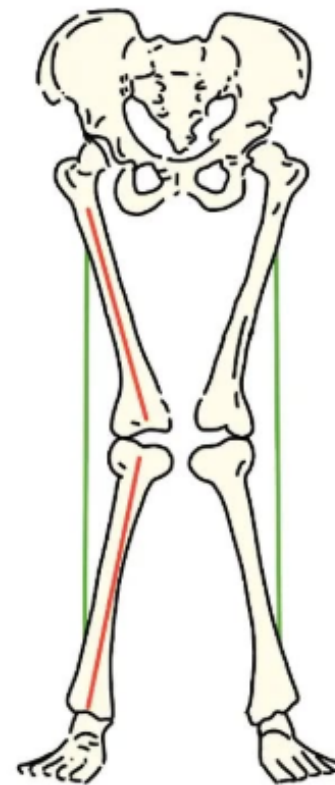
GenuValgo

Deformidad de la rodilla en el plano frontal, los pies están separados cuando las rodillas están juntas, llamadas también piernas en forma de tiejero o equis“X”, la deformidad es más notoria cuando el niño está en bipedestación y generalmente se asocia con pies planos valgos. En el genu valgo se produce una sobrecarga por compresión del compartimento externo de la rodilla y por distensión del ligamento lateral interno y músculos de la cara interna de la rodilla (pata de ganso, poplíteo y semimembranoso en su inserción distal).



GENU VALGO

GENU VALGO



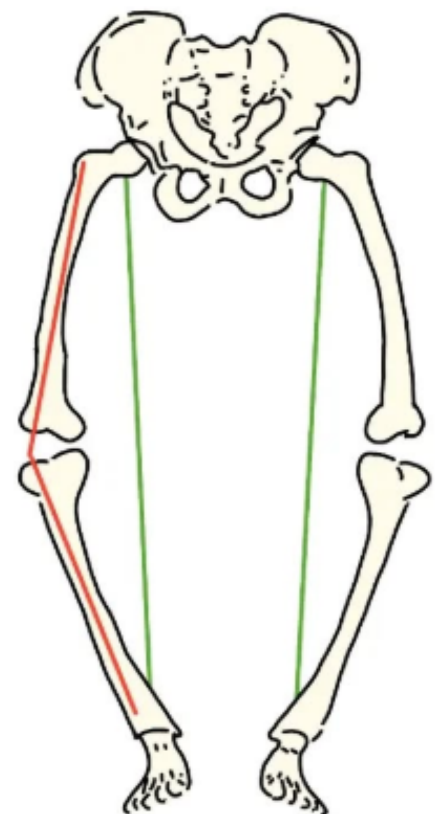
GenuVaro

La rodillas están separadas cuando los pies están juntos, llamadas también piernas arqueadas o piernas en paréntesis “()”, generalmente asociadas a tibias varas. La deformidad conduce a una sobrecarga del compartimento interno con degeneración atrósica del menisco en el adulto, así como una distensión e inestabilidad del ligamento lateral externo y músculos de la cara externa en su inserción distal TFL, bíceps corto.



GENU VARO

GENU VARO



CAUSAS:

GENU VALGO

- *Proceso natural de crecimiento
- Proceso natural de crecimiento
- Hiperlaxitud ligamentaria
- Posturas incorrectas
- Sobrepeso
- Trastornos del crecimiento: distrofia osteocondral
- Raquitismo
- Alteraciones metabólicas
- Compensación de deformidades relacionadas a traumatismos, parálisis.



GENU VARO

- Genu varo fisiológico infantil
- Desarrollo óseo anormal
- Raquitismo
- Artrosis de rodillas
- Lesiones postraumáticas
- Acondroplasias
- Enfermedad de Blount



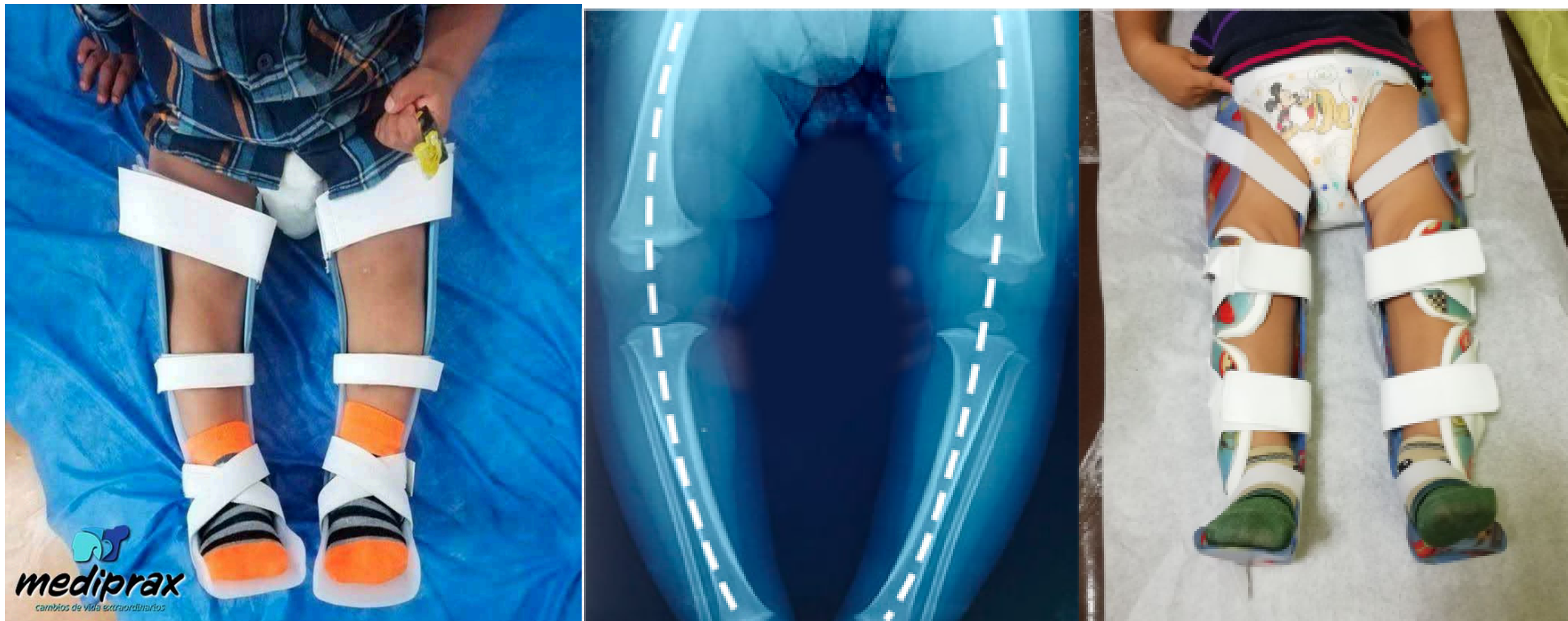
TRATAMIENTO ORTOPÉDICO

Genu valgo



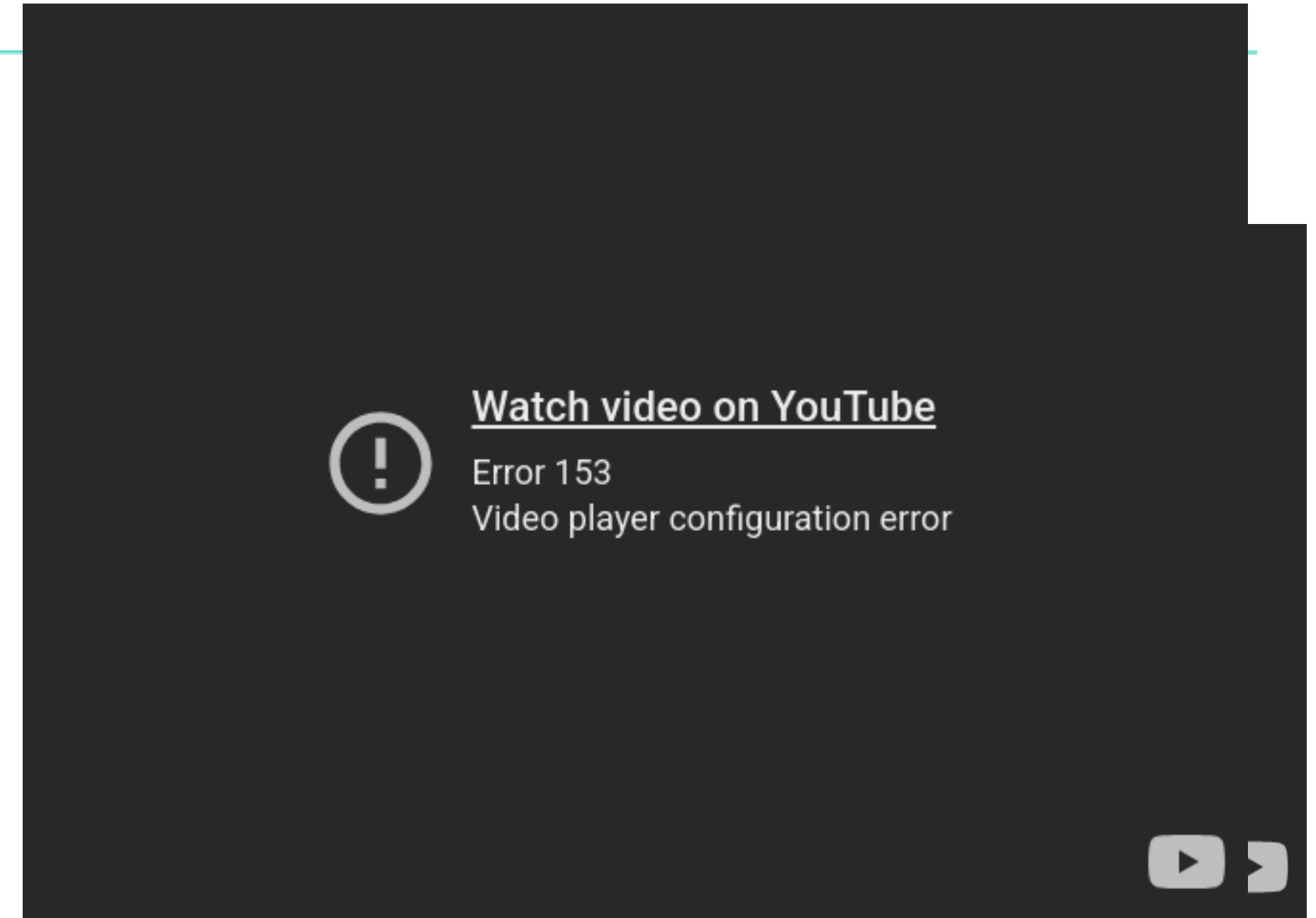
TRATAMIENTO ORTOPÉDICO

Genu varo



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Para los niños en crecimiento, las opciones incluyen la cirugía de crecimiento guiado (mediante implantes que ralentizan el crecimiento del lado afectado) o, en adultos y casos severos, las osteotomías correctoras, que implican cortar y realinear el hueso (tibia o fémur).



- Cirugía de crecimiento guiado: Se colocan pequeños dispositivos metálicos en las placas de crecimiento de la rodilla para controlar el crecimiento óseo.
- Osteotomía correctiva: Se corta y reposiciona el hueso para corregir el ángulo de la pierna, luego se estabiliza con placas y tornillos.

TRATAMIENTO REHABILITADOR

Objetivo general:

- Mejorar el alineamiento de la rodilla en el plano frontal, buscando que las carillas articulares estén horizontales y paralelas.

Objetivos específicos:

- Preparación y mejora de tono muscular.
- Mejorar la movilidad
- Fortalecimiento muscular
- Control postural
- Reeducación de la marcha



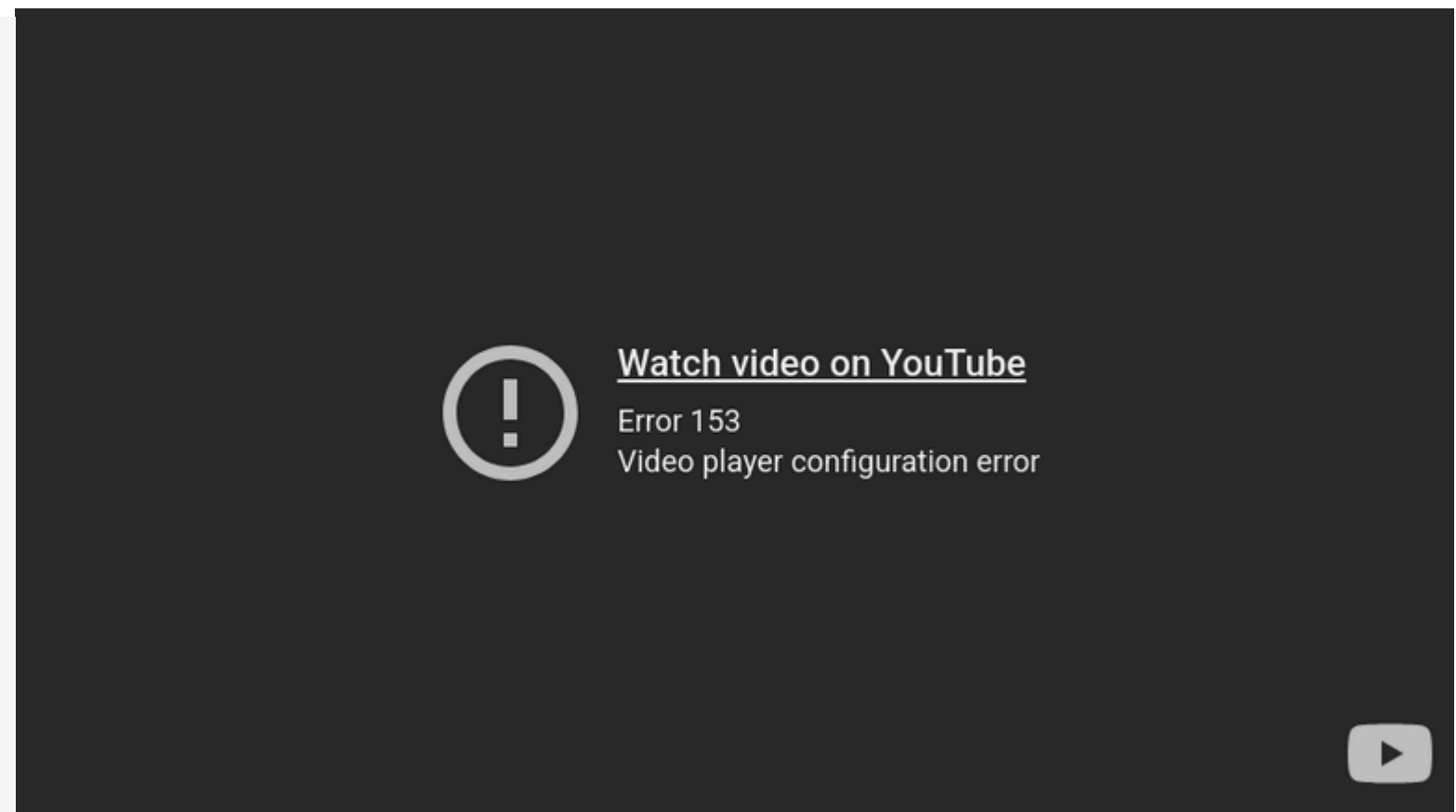
TIBIAS VARAS

Es una deformidad del eje longitudinal de la tibia, se produce una angulación en la diáfisis tibial a diferente nivel, se observa una convexidad externa de la diáfisis tibial en el plano frontal.



Causas

- Enfermedad de Blount
- Raquitismo
- Factores genéticos
- Sobrecarga mecánica
- Artrosis en adultos



Muchas gracias

Presente.